

성인 Daily Day 05 - 이상지질혈증

1차진료

검진 이상

KCD E78.x

작성일 2026-05-15

오늘의 목표

검진 지질 이상 환자에서 statin 시작 여부, 강도, LFT/근육통 상담, 추적검사, 의뢰 기준을 정한다. 총콜레스테롤보다 ASCVD 병력, LDL-C, TG, 당뇨/CKD/흡연/고혈압/가족력이 중요하다.

1. 배경지식

이상지질혈증은 동네 의원 검진 상담의 핵심 반복 질환이다. 1차진료에서는 이미 ASCVD가 있는지, LDL-C가 190 mg/dL 이상인지, 당뇨와 주요 위험인자가 있는지를 먼저 본다. TG가 500 mg/dL 이상이면 췌장염 예방도 같이 생각한다.

2. 첫 3분 Triage

즉시/당일 의뢰: 흉통·호흡곤란·신경학적 결손, TG 1000 mg/dL 전후 + 복통/구토, CK 현저 상승/콜라색 소변/급성 신손상, AST/ALT 3배 이상 지속 상승 또는 황달.

1. ASCVD 병력과 당뇨/CKD/흡연/고혈압을 확인한다.
2. LDL-C 190 이상 또는 TG 500 이상인지 본다.
3. 임신 가능성, 수유, 활동성 간질환, 과거 statin 부작용을 확인한다.
4. 상호작용 약물: macrolide, azole, cyclosporine, HIV/HCV 약제, gemfibrozil.
5. 오늘 결론을 생활요법 단독, statin 시작, TG 치료, 의뢰 중 하나로 정한다.

3. 핵심 문진/PE

문진 5문항

1. 심근경색, 협심증, 스텐트, 뇌졸중, 말초혈관질환 병력이 있는가?
2. 조기 심혈관질환 가족력이 있는가?
3. 당뇨, 고혈압, 흡연, CKD, 갑상선질환, 지방간이 있는가?
4. 술, 단 음식, 야식, 체중 증가, 운동 부족이 있는가?
5. 임신 가능성, 수유, 근육병, statin 부작용, 상호작용 약물이 있는가?

Physical exam

- 혈압, BMI, 허리둘레: 대사증후군과 전체 위험도.
- 건황색종, 손바닥 황색종, 각막한: 가족성 고콜레스테롤혈증 단서.
- 갑상선비대/서맥/부종, 간비대, 말초맥박, 경동맥 bruit.

4. 검사

상황	검사	해석/행동
초진/검진 이상	Lipid profile	LDL-C, TG, HDL-C, non-HDL-C 확인. TG 높으면 공복 재검.

상황	검사	해석/행동
Statin 시작 전	AST/ALT	기준값 확보. 활동성 간질환이면 평가 후 시작.
근육증상 위험	CK	routine은 아님. 근육병, 과거 intolerance, 상호작용 약물, 원인불명 근육통이면 확인.
2차 원인	HbA1c/FBS, TSH, Cr/eGFR, urine ACR, LFT	당뇨, 갑상선저하증, CKD/nephrotic, 지방간/담즙정체 확인.
시작/증량 후	Lipid profile 4-12주	LDL 감소율과 순응도 확인. 이후 3-12개월 간격.

5. KCD 코드

E78.0	순수 고콜레스테롤혈증. LDL-C 중심 상승.
E78.1	순수 고글리세라이드혈증. TG 중심 상승.
E78.2	혼합성 고지질혈증. LDL/TG 동반 상승.
E78.5	상세불명의 고지질혈증. 검진 이상 초기.
E11.x/I10/N18.x/K76.0	당뇨, 고혈압, CKD, 지방간 동반 시 근거에 따라 부상병.

6. 처방 Regimen

상황	1차 접근	목표/추적
ASCVD 병력	High-intensity 또는 최대 내약 statin	LDL-C 50% 이상 감소, 고위험 목표 고려.
LDL-C ≥ 190	High-intensity statin	가족성 고콜레스테롤혈증 평가.
당뇨 40-75세	최소 moderate-intensity	위험인자 많거나 50세 이상이면 high-intensity 고려.
TG 200-499	LDL/non-HDL 중심 statin	금주, 체중, 당 조절, 단순당 제한.
TG ≥ 500	췌장염 예방 우선	금주, 저지방식, 당 조절, fenofibrate/omega-3 검토.

강도	약제 예	메모
Moderate	Atorvastatin 10-20 mg qd	상호작용 확인.
Moderate	Rosuvastatin 5-10 mg qd	신기능 저하, 고령에서 낮게 시작.
Moderate	Pitavastatin 2-4 mg qd	상호작용/당뇨 우려 맥락에서 선택 가능.
High	Atorvastatin 40-80 mg qd	ASCVD, LDL ≥ 190 , 고위험 당뇨.
High	Rosuvastatin 20 mg qd	eGFR 낮으면 용량 주의.

임신 가능성/수유, 활동성 간질환, 설명 안 되는 AST/ALT 상승, 과거 rhabdomyolysis, CYP3A4 inhibitor와 gemfibrozil 병용을 확인한다. 근육통이 있으면 CK/Cr를 보고 중단-재도전-전환 전략을 쓴다.

7. Follow-up / Refer

- 시작/증량 후 4-12주: lipid profile, 순응도, 부작용 확인.
- 안정화 후 3-12개월마다 lipid profile. 당뇨/간질환/다약제는 더 짧게.
- LDL 190 이상 + 가족력/황색종/반응 부족, TG 1000 전후, 췌장염 증상, CK 10배 이상, rhabdomyolysis, AST/ALT 3배 이상 지속 상승은 의뢰.

8. 환자 설명 스크립트

콜레스테롤 약은 수치를 예쁘게 만드는 약이라기보다 앞으로 심근경색과 뇌졸중 위험을 낮추기 위한 약입니다.

간수치와 근육통은 시작 전 기준값을 확인하고 증상이 생기면 바로 조정할 수 있습니다. 대부분은 안전하게 오래 복용합니다.

근육통이 생기면 참으면서 계속 드시지 말고 연락 주세요. 약을 잠시 쉬거나 다른 종류/낮은 용량으로 바꿀 수 있습니다.

술, 단 음식, 야식, 체중 증가가 특히 중성지방을 올립니다. 중성지방이 아주 높으면 췌장염 위험도 있습니다.

임신을 계획하거나 임신 가능성이 생기면 statin은 바로 상의해야 합니다.

9. 자가체크

1. LDL-C 190 이상에서 확인할 가족성 고콜레스테롤혈증 단서는?
2. 당뇨 40-75세 환자의 statin 강도 결정 인자는?
3. TG 500 이상과 1000 전후에서 놓치면 안 되는 위험은?
4. Statin 시작 전 routine 검사와 CK를 선택적으로 확인하는 상황은?
5. Statin 근육통 호소 시 중단/검사/재도전 전략은?

참고 출처

KSoLA Korean Guidelines for the Management of Dyslipidemia 5th, 2022: https://www.lipid.or.kr/eng/pub/images/guidelines_2022.pdf

ACC/AHA 2018 Cholesterol Guideline: <https://www.acc.org/latest-in-cardiology/ten-points-to-remember/2018/11/09/14/28/2018-guideline-on-management-of-blood-cholesterol>

NCBI Bookshelf Atorvastatin monitoring: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430779/>